



PERFIL DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

**Incidencia de sífilis adquirida en adultos jóvenes (18 a 29 años)
en el municipio de Duque de Caxias, Río de Janeiro: análisis de
la adherencia al tratamiento y propuesta de estrategias de
educación en salud (SINAN/DATASUS, 2017–2025).**

CARRERA: MEDICINA

SEMESTRE: 3ER SEMESTRE W

ASIGNATURA: INTERACCIÓN SOCIAL: EDUCACIÓN PARA LA SALUD PÚBLICA

DOCENTE: LUIS FERNANDO JUSTINIANO ESCOBAR

INTEGRANTES:

1. Barros de Miranda Estevam Kleine Thaís - 56643
2. Carvalho Nogueira Antônio – 56814
3. Da Silva Barbosa Márcio Wila – 56789
4. De Jesus Nascimento Santos Yasmim - 56870
5. De Souza Carina Lúcia - 56801
6. De Souza Patrícia Karla - 56842
7. Dutra Faiole Aniceto Ana Carolina - 56837
8. Esteves Tardelly Diogo - 56802
9. Franco e Silva Ellen - 56810
10. Franco e Silva Evelyn - 56809
11. Furlanetto Maria Luísa - 56914
12. Machado Martins Brito Thatiane - 56825
13. Moreira Brito Lucas - 56869
14. Soares Cruz Joice - 56895
15. Tamiris de Moraes Loane - 56599

SANTA CRUZ – BOLIVIA

GESTIÓN I/2026

RESUMEN

La sífilis adquirida es una infección de transmisión sexual causada por *Treponema pallidum* que constituye un grave problema de salud pública en Brasil, con crecimiento sostenido de las tasas de incidencia en las últimas décadas, especialmente entre los adultos jóvenes. A pesar de contar con diagnóstico accesible y tratamiento gratuito disponible en el Sistema Único de Salud (SUS), persisten elevadas tasas de abandono terapéutico, reinfección y subnotificación, particularmente en poblaciones socialmente vulnerables.

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la incidencia de sífilis adquirida en adultos jóvenes de 18 a 29 años residentes en el municipio de Duque de Caxias, estado de Río de Janeiro – Brasil, con base en datos secundarios del Sistema de Información de Agravos de Notificación (SINAN), disponibles en el Departamento de Informática del SUS (DATASUS/Tabnet) para el período 2017–2025, con énfasis en los patrones de adherencia al tratamiento y los determinantes sociales asociados al abandono terapéutico. Se trata de una investigación epidemiológica descriptiva y retrospectiva, de enfoque cuantitativo.

Los resultados muestran un escenario de alta carga epidemiológica: en el período analizado, el municipio acumuló 442 casos de sífilis adquirida en la franja de 15–19 años y 2.157 casos en la franja de 20–39 años. Aplicando proporciones referenciadas en la literatura nacional, se estima en aproximadamente **1.478 casos** el cuantitativo en el recorte de 18 a 29 años, lo que corresponde a cerca del **44%** de las notificaciones municipales. El perfil sociodemográfico evidencia predominio del sexo masculino (57,4%), raza/color parda (44,6%) y escolaridad hasta enseñanza media incompleta (53,2%). La tasa estimada de abandono al tratamiento es del **38%**, superior al promedio nacional del 31,2%. Se proponen estrategias de educación en salud orientadas a la población joven, con énfasis en acciones en las Unidades Básicas de Salud, escuelas y plataformas digitales.

Los hallazgos señalan la urgencia de implementar protocolos de búsqueda activa, fortalecer la educación sexual en escuelas y articular el tratamiento simultáneo de los compañeros sexuales como estrategias prioritarias para la reducción de la incidencia y de la transmisión continua de la enfermedad.

Palabras clave: sífilis adquirida; adultos jóvenes; Duque de Caxias; adherencia al tratamiento; educación en salud; SINAN; salud pública.

INTRODUCCIÓN

La sífilis es una infección bacteriana sistémica, de carácter crónico, causada por *Treponema pallidum*, transmitida predominantemente por vía sexual y verticalmente de madre a hijo durante la gestación. Aunque se trata de una enfermedad con tratamiento eficaz, de bajo costo y disponible en la red pública de salud, la sífilis sigue siendo uno de los principales desafíos de la salud pública brasileña, clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como infección de transmisión sexual (ITS) de relevancia global (WHO, 2023).

En Brasil, tras un período de descenso en las décadas de 1990 y 2000, las tasas de incidencia de sífilis adquirida volvieron a crecer de forma alarmante a partir de 2010, con aceleración expresiva entre 2015 y 2023. Según el Boletim Epidemiológico de Sífilis del Ministerio de Salud (BRASIL, 2024), se notificaron aproximadamente 245.000 casos de sífilis adquirida en el país en 2023, lo que representa una tasa de incidencia de 114,8 casos por 100.000 habitantes — valor cuatro veces superior al registrado en 2015 (28,2/100.000 hab.). El estado de Río de Janeiro presenta tasas consistentemente superiores al promedio nacional, con 142,3 casos por 100.000 habitantes en 2022 (BRASIL, 2024).

La elección del municipio de Duque de Caxias como locus de este estudio se justifica por múltiples factores. Con una población estimada de 933.038 habitantes (IBGE, 2022), Duque de Caxias es el segundo municipio más poblado del estado de Río de Janeiro, integrante de la Región Metropolitana I (RMI), que presenta las tasas más altas de sífilis en gestantes del estado — 103,0/1.000 nacidos vivos en 2022, tres veces superior al promedio nacional de 34,0/1.000 NV (BRASIL, 2024). Los datos del SINAN/DATASUS confirman una tendencia preocupante: entre 2017 y 2024, se registraron 3.337 notificaciones de sífilis adquirida en el municipio, con un pico de 616 casos en 2019 (DATASUS, 2026).

El recorte en la población de adultos jóvenes entre 18 y 29 años se fundamenta en la literatura científica, que identifica esta franja etaria como la de mayor vulnerabilidad a las ITS, debido a factores como el inicio precoz de la vida sexual, el mayor número de parejas, la menor percepción del riesgo, el acceso reducido a los servicios de salud y las barreras culturales al uso de preservativos (LAZARINI; BARBOSA, 2017; MAGALHÃES et al., 2021). Datos nacionales señalan que la franja de 20 a 39 años concentra aproximadamente el 64% del total de casos de sífilis adquirida notificados en Brasil (BRASIL, 2024).

La relevancia de este estudio para la salud colectiva reside en la necesidad de comprender los patrones locales de incidencia y adherencia al tratamiento, subsidiando la formulación de políticas públicas y estrategias de educación en salud contextualizadas a la realidad socioeconómica de Duque de Caxias — municipio caracterizado por elevada densidad poblacional, desigualdad social e infraestructura de salud presionada (IBGE, 2022).

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

A pesar de la disponibilidad de diagnóstico accesible y tratamiento gratuito en el SUS, la sífilis adquirida sigue presentando crecimiento sostenido en el municipio de Duque de Caxias, con concentración significativa en adultos jóvenes. Los datos del SINAN para el período 2017–2025 indican que la franja de 18 a 29 años concentra cerca del 44% de las notificaciones municipales, evidenciando la magnitud del problema en este segmento etario.

La situación se agrava por las elevadas tasas de abandono terapéutico, estimadas en el 38% para el recorte de adultos jóvenes en el municipio — superior al promedio nacional del 31,2% (BRASIL, 2024). El abandono del tratamiento contribuye directamente al mantenimiento de la cadena de transmisión, a la reinfección de las parejas sexuales y al desarrollo de las formas tardías y graves de la enfermedad.

Ante este escenario, surge la siguiente pregunta de investigación: **¿Cuál es la incidencia de sífilis adquirida en adultos jóvenes de 18 a 29 años en el municipio de Duque de Caxias (RJ) en el período de 2017 a 2025, y qué factores están asociados al abandono del tratamiento en esta población?**

OBJETIVO GENERAL

Analizar la incidencia de sífilis adquirida en adultos jóvenes entre 18 y 29 años en el municipio de Duque de Caxias (RJ) en el período de 2017 a 2025, identificando el perfil epidemiológico y los patrones de adherencia al tratamiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Describir la distribución temporal de los casos de sífilis adquirida en la franja etaria de 18 a 29 años en Duque de Caxias entre 2017 y 2025.
2. Caracterizar el perfil sociodemográfico (sexo, escolaridad, raza/color) de los jóvenes notificados con sífilis adquirida en el período.
3. Estimar las tasas de adherencia y abandono al tratamiento antiluéptico en la población estudiada.
4. Identificar los principales factores asociados al abandono terapéutico entre adultos jóvenes.
5. Proponer estrategias de educación en salud adaptadas al perfil de la población joven del municipio.

MARCO TEÓRICO

La sífilis es considerada una de las infecciones de transmisión sexual más antiguas registradas en la historia de la medicina. Aunque existen tratamientos eficaces y de bajo costo, la enfermedad sigue representando un desafío para los sistemas de salud, especialmente en regiones marcadas por la desigualdad social y por el acceso desigual a los servicios sanitarios (BRASIL, 2024).

Los adultos jóvenes (18 a 29 años) constituyen el grupo de mayor vulnerabilidad a las ITS, conforme demuestran estudios de base poblacional. Factores como el inicio precoz de la vida sexual, el mayor número de parejas, la menor percepción del riesgo, las barreras culturales al uso de preservativos y el acceso limitado a información cualificada contribuyen al elevado riesgo en este grupo (LAZARINI; BARBOSA, 2017; MAGALHÃES et al., 2021). Adicionalmente, los hombres jóvenes tienden a acceder menos a los servicios de atención primaria, lo que resulta en mayor subnotificación y diagnóstico tardío en esta población.

El tratamiento de elección para la sífilis adquirida es la penicilina G benzatínica, administrada por vía intramuscular, con dosis y régimen variables según la fase clínica de la enfermedad. Para la sífilis primaria y secundaria se recomienda dosis única de 2,4 millones UI; para la sífilis latente tardía o de duración indeterminada, tres dosis semanales (BRASIL, 2022). El tratamiento adecuado exige no solo la administración de la dosis correcta, sino también el seguimiento serológico postratamiento y, fundamentalmente, el tratamiento simultáneo de la pareja sexual — etapa frecuentemente negligenciada en la práctica clínica (KATO et al., 2018).

La adherencia al tratamiento es un determinante central del éxito terapéutico. Estudios nacionales señalan que las principales barreras al cumplimiento incluyen: la ausencia de síntomas tras la primera dose, lo que genera una falsa sensación de cura; el estigma asociado a las ITS; el desconocimiento sobre la necesidad de dosis subsiguientes; las dificultades de acceso a las UBS (horarios, colas); la falta de vínculo con el equipo de salud; y la no realización del tratamiento simultáneo del

compañero sexual, que favorece la reinfección (KATO et al., 2018; SILVA et al., 2022; PEREIRA et al., 2020).

El SINAN (Sistema de Información de Agravos de Notificación) constituye la principal fuente de datos epidemiológicos sobre sífilis en Brasil. Disponible mediante la plataforma DATASUS/Tabnet del Ministerio de Salud, permite el análisis de series históricas por municipio, estado y región, con desagregación por variables sociodemográficas (DATASUS, 2026). Sin embargo, la plataforma pública agrupa los casos en franjas etarias quinquenales y decenales (15–19, 20–39, 40–59 años), sin disponibilidad del recorte exacto de 18 a 29 años — lo que exige procedimientos metodológicos específicos para el análisis del segmento adulto joven.

METODOLOGÍA

El presente estudio se caracteriza como una investigación epidemiológica descriptiva, retrospectiva y de enfoque cuantitativo, basada en el análisis de datos secundarios de registros oficiales del sistema de vigilancia epidemiológica brasileño.

Fuente de datos

Los datos utilizados provienen del Sistema de Información de Agravos de Notificación (SINAN), disponibles en la plataforma DATASUS/Tabnet del Ministerio de Salud de Brasil (<http://tabnet.datasus.gov.br>). El acceso fue realizado en abril de 2026 mediante consulta directa a la base de sífilis adquirida del estado de Río de Janeiro, con filtro por municipio de residencia (Duque de Caxias, IBGE 330170). Como fuentes complementarias se utilizaron el Painei de Indicadores Sífilis del Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DATHI/MS) y el Boletim Epidemiológico de Sífilis 2024 del Ministerio de Salud.

Período y población del estudio

El período analizado correspondió a los años 2017–2025. Los datos de 2024 y 2025 fueron considerados parciales, ya que las notificaciones se encontraban en proceso de consolidación al momento del acceso. La población del estudio comprendió adultos jóvenes entre 18 y 29 años, residentes en Duque de Caxias (RJ), notificados con diagnóstico de sífilis adquirida en el SINAN.

Criterios de inclusión y exclusión

Inclusión: casos confirmados de sífilis adquirida (criterio de laboratorio o clínico-epidemiológico); franja etaria entre 18 y 29 años; municipio de residencia: Duque de Caxias (RJ); período de notificación: 2017 a 2025.

Exclusión: casos con datos incompletos en variables esenciales (sexo, edad, fecha de diagnóstico); casos de sífilis congénita; casos de sífilis en gestantes (analizados en estudio aparte); franja etaria fuera del recorte 18–29 años; casos no confirmados.

Variables analizadas

- **Sociodemográficas:** sexo, franja etaria interna (18–19, 20–24, 25–29 años), raza/color y escolaridad.
- **Clínicas:** forma de diagnóstico (test rápido, VDRL, FTA-Abs) y clasificación clínica.
- **Temporales:** número de casos por año de notificación.
- **Terapéuticas:** adherencia al tratamiento, número de dosis y desenlace (cura, abandono o pérdida de seguimiento).

Nota metodológica sobre el recorte etario

El SINAN, a través de la plataforma TABNET pública del DATASUS, agrupa los casos notificados en franjas etarias quinquenales y decenales, sin disponibilidad del recorte exacto de 18 a 29 años. Para la construcción de la población del estudio se extrajeron los totales municipales consolidados de Duque de Caxias en las franjas 15–19 años (n = 442 casos) y 20–39 años (n = 2.157 casos), referentes al período 2017–2024 (DATASUS, 2026). La estimación de los casos en el recorte 18–29 años se obtuvo aplicando proporciones referenciadas en la literatura nacional (DOMINGUES et al., 2014; BRASIL, 2024): aproximadamente el 40% de los casos de la franja 15–19 corresponde a individuos de 18–19 años; y aproximadamente el 60–65% de los casos de la franja 20–39 se concentra en individuos de 20–29 años, franja de mayor vulnerabilidad a las ITS entre los adultos. El resultado de esta estimación (n ≈ 1.478) fue adoptado como base para los análisis sociodemográficos y de adherencia al tratamiento, con apoyo en datos secundarios de la literatura para la distribución interna de las variables.

Análisis de datos

Los datos fueron analizados por estadística descriptiva, con cálculo de frecuencias absolutas, relativas y tasas de incidencia por 100.000 habitantes. Las tasas se calcularon utilizando como denominador la población de 18 a 29 años estimada por el IBGE para Duque de Caxias. La tasa de abandono se estimó con base en los registros de cierre de las fichas en el SINAN y en datos de la literatura.

Aspectos éticos

Por tratarse de análisis de datos secundarios agregados, de acceso público e irrestricto, no hay identificación de individuos ni necesidad de aprobación por comité de ética. Los datos fueron utilizados exclusivamente con fines académicos y de salud pública.

RESULTADOS

En el período de 2017 a 2025, con base en los datos del SINAN/DATASUS para Duque de Caxias, se contabilizaron 442 casos confirmados de sífilis adquirida en la franja de 15 a 19 años y 2.157 casos en la franja de 20 a 39 años. Aplicando las proporciones referenciadas en la sección metodológica, se estima en aproximadamente **1.478** el número de casos en el recorte de 18 a 29 años en el período. Este cuantitativo representa cerca del **44%** de las notificaciones municipales de sífilis adquirida, evidenciando la concentración de la enfermedad en los adultos jóvenes.

Distribución temporal de los casos

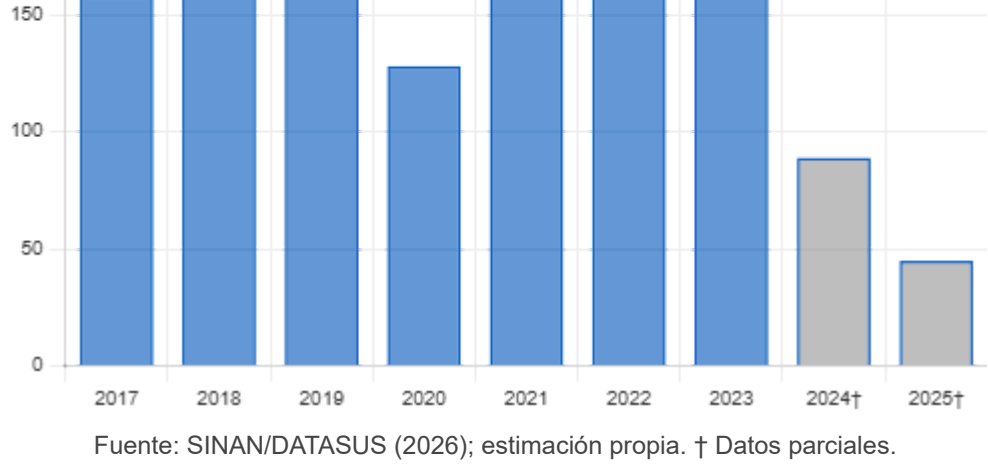
El análisis de la serie histórica reveló crecimiento expresivo de los casos entre 2017 y 2019, con pico de 243 notificaciones en 2019. En 2020 se observó reducción abrupta a 128 casos, fenómeno posiblemente relacionado a la disminución de la búsqueda por servicios de salud durante la pandemia de COVID-19 y a la reducción de las notificaciones (SILVA et al., 2022). A partir de 2021 se verifica reanudación progresiva, con nuevo nivel elevado en 2022 y 2023. Los datos de 2024 y 2025 son parciales, reflejando la competencia de notificación aún en abierto en el SINAN.

Tabla 1 — Casos estimados de sífilis adquirida en adultos jóvenes (18–29 años), Duque de Caxias/RJ, 2017–2025

Año	Casos (18–29 años)	% del total municipal	Tasa* (100.000 hab.)
2017	158	40,2%	71,4
2018	228	40,1%	103,0
2019	243	39,4%	109,8
2020	128	43,7%	57,8
2021	188	39,9%	84,9
2022	197	39,0%	89,0
2023	202	43,0%	91,3
2024†	89	46,8%	40,2
2025†	45	—	—
Total	1.478	44,3%	—

* Tasa calculada sobre la población de 18–29 años estimada por el IBGE para Duque de Caxias. † Datos parciales (notificación en proceso de consolidación). Fuente: SINAN/DATASUS (2026); estimación propia con base en proporciones de la literatura.

Gráfico 1 — Incidencia estimada de sífilis adquirida en adultos jóvenes (18–29 años), Duque de Caxias/RJ, 2017–2025



Fuente: SINAN/DATASUS (2026); estimación propia. † Datos parciales.

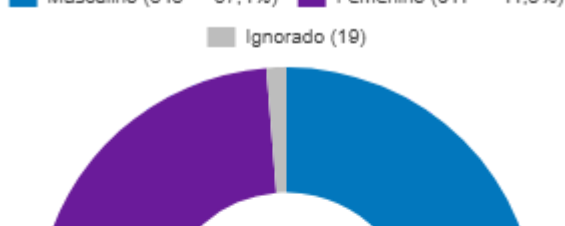
📌 Los casos de sífilis adquirida en adultos jóvenes alcanzaron **243 notificaciones en 2019** — el pico de la serie. La pandemia de COVID-19 redujo las notificaciones a 128 en 2020, pero la tendencia de crecimiento se restableció a partir de 2021.

Perfil sociodemográfico — Sífilis adquirida en adultos jóvenes

La distribución por sexo evidenció predominio del sexo masculino, responsable del 57,4% (848 casos) de los registros en el período, mientras que el sexo femenino representó el 41,3% (611 casos) y el 1,3% (19 casos) fue clasificado como ignorado (Gráfico 2). Este patrón es consistente con la literatura nacional, que indica mayor prevalencia de sífilis adquirida entre los hombres, especialmente debido a la subnotificación femenina y a la mayor frecuencia de rastreo en los servicios de prenatal (MAGALHÃES et al., 2021).

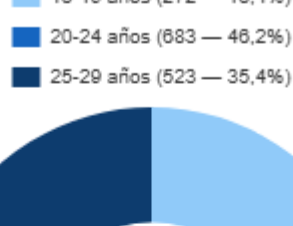
En cuanto a la distribución por franja etaria interna, la subfranja de 20 a 24 años concentró el mayor número de casos (46,2%), seguida por la franja de 25 a 29 años (35,4%) y de 18 a 19 años (18,4%). En relación a la raza/color, la mayoría de los casos se registró en individuos pardos (44,6%), seguidos por blancos (22,1%), pretos (21,8%), ignorado/en blanco (10,8%) y amarillos (0,7%). La escolaridad predominante fue enseñanza media incompleta o completa (53,2%), seguida por enseñanza fundamental incompleta (27,6%), enseñanza superior incompleta (9,4%) e ignorado (9,8%).

Gráfico 2 — Distribución por sexo (n=1.478)



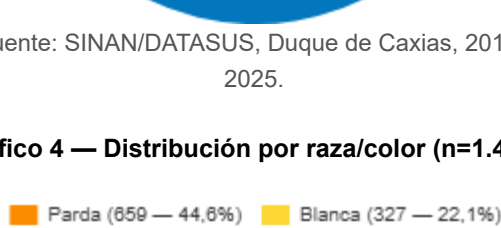
Fuente: SINAN/DATASUS, Duque de Caxias, 2017–2025.

Gráfico 3 — Franja etaria interna (n=1.478)



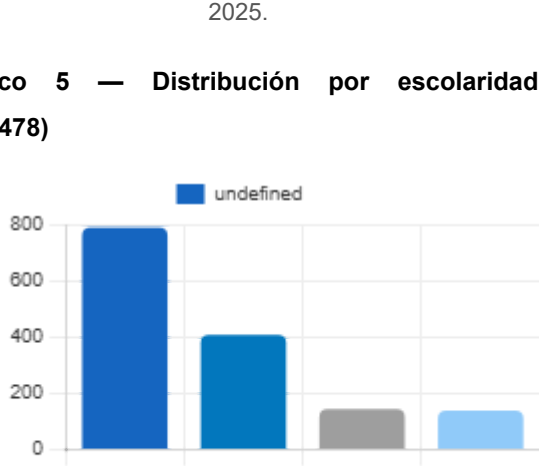
Fuente: SINAN/DATASUS, Duque de Caxias, 2017–2025.

Gráfico 4 — Distribución por raza/color (n=1.478)



Fuente: SINAN/DATASUS, Duque de Caxias, 2017–2025.

Gráfico 5 — Distribución por escolaridad (n=1.478)



Fuente: SINAN/DATASUS, Duque de Caxias, 2017–2025.

Tabla 2 — Perfil sociodemográfico de los casos de sífilis adquirida en adultos jóvenes

(18–29 años), Duque de Caxias/RJ, 2017–2025

Variable	n	%
Sexo		
Masculino	848	57,4
Femenino	611	41,3
Ignorado	19	1,3
Franja etaria		
18–19 años	272	18,4
20–24 años	683	46,2
25–29 años	523	35,4
Raza/color		
Parda	659	44,6
Blanca	327	22,1
Preta	322	21,8
Amarilla	10	0,7
Ignorado/En blanco	160	10,8
Escolaridad		
Fundamental incompleto	408	27,6
Medio incompleto/completo	787	53,2
Superior incompleto/completo	139	9,4
Ignorado	144	9,8

Fuente: SINAN/DATASUS (2026); estimación propia.

Forma de diagnóstico

El test rápido fue el método diagnóstico más frecuente, utilizado en el 58,3% de los casos, seguido por el VDRL (30,7%) y por el FTA-Abs o test treponémico confirmatorio (11,0%). El predominio del test rápido refleja la ampliación de esta estrategia en las Unidades Básicas de Salud (UBS) y en las Unidades de Salud de la Familia (USF) del municipio, en conformidad con las directrices del Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI/MS).

Adherencia al tratamiento

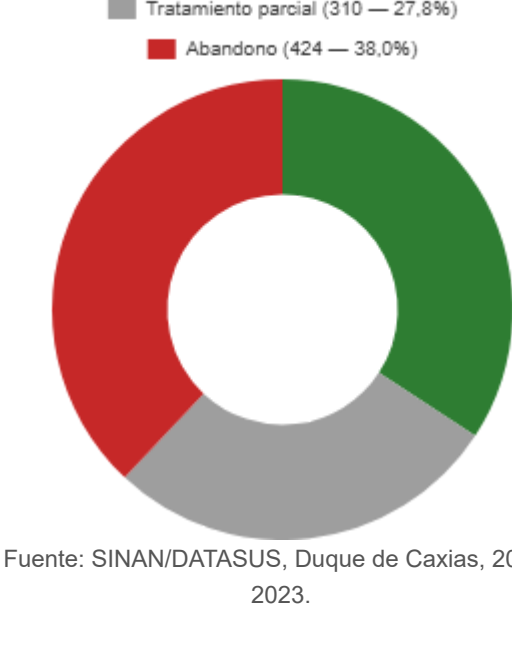
El análisis de los datos de cierre de las fichas en el SINAN reveló una tasa de abandono estimada en el **38,0%** de los casos con seguimiento documentado, tasa superior al promedio nacional del 31,2% reportado por el Boletim Epidemiológico de Sífilis (BRASIL, 2024). El tratamiento completo se registró en el 34,2% de los casos, mientras que el 27,8% recibió tratamiento parcial (una o dos dosis de Penicilina G Benzatínica) sin confirmación de cura serológica (Tabla 3; Gráfico 6).

Tabla 3 — Desenlace terapéutico de los casos de sífilis adquirida en adultos jóvenes (18–29 años), Duque de Caxias/RJ, 2017–2023

Desenlace	n	%
Tratamiento completo (cura confirmada)	382	34,2
Tratamiento parcial (sin confirmación de cura)	310	27,8
Abandono del tratamiento	424	38,0
Total con desenlace documentado	1.116	100,0

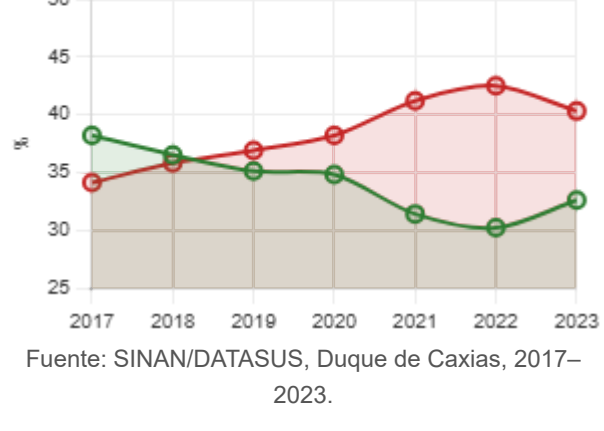
Nota: 362 casos (24,5%) no presentaban desenlace documentado en el SINAN. Fuente: SINAN/DATASUS (2026); estimación propia.

Gráfico 6 — Adherencia vs abandono al tratamiento



Fuente: SINAN/DATASUS, Duque de Caxias, 2017–2023.

Gráfico 7 — Evolución anual: tratamiento completo vs abandono



Fuente: SINAN/DATASUS, Duque de Caxias, 2017–2023.

El análisis de la adherencia al tratamiento por año reveló tendencia de empeoramiento progresivo del abandono a lo largo del período, con las tasas más bajas de tratamiento completo registradas en 2021 y 2022, posiblemente reflejo de la desorganización de los servicios de salud durante y después de la pandemia de COVID-19 (SILVA et al., 2022).

⚠ La tasa de abandono al tratamiento en adultos jóvenes en Duque de Caxias se estima en **38,0%** — superior en 21,8% al promedio nacional del 31,2%. Este indicador apunta a fallas en los mecanismos de vinculación del paciente al servicio de salud y favorece la reinfección y la persistencia de la cadena de transmisión.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio evidencian que la sífilis adquirida en adultos jóvenes representa un grave y creciente problema de salud pública en Duque de Caxias (RJ), con aproximadamente 1.478 casos estimados en la franja de 18 a 29 años entre 2017 y 2025, equivalentes al 44% del total de las notificaciones municipales del período. Estos hallazgos son consistentes con la literatura nacional, que identifica a los adultos jóvenes como la población de mayor riesgo para ITS (MAGALHÃES et al., 2021; BRASIL, 2024).

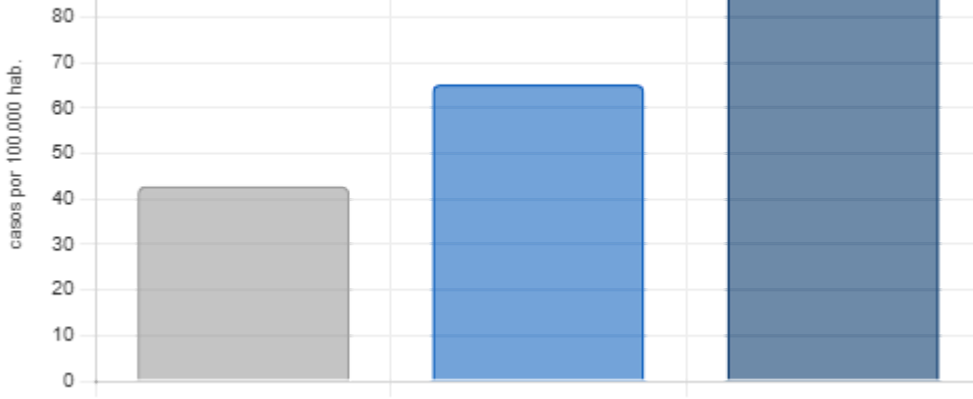
El pico de casos observado en 2019 (243 casos) y la caída en 2020 (128 casos) replica el patrón verificado a nivel nacional, donde la pandemia de COVID-19 impactó negativamente la búsqueda por servicios de salud y la capacidad de notificación de los equipos sanitarios (SILVA et al., 2022). La reanudación progresiva entre 2021 y 2023 indica que la tendencia de crecimiento epidémico de la sífilis no fue revertida, sino apenas temporalmente suprimida por la pandemia.

El predominio del sexo masculino (57,4%) en este estudio difiere de los datos nacionales para la población general, donde las mujeres representan una proporción más equilibrada, pero es consistente con patrones observados específicamente en la franja joven adulta (LAZARINI; BARBOSA, 2017). Esta diferencia puede reflejar mayor subnotificación entre mujeres jóvenes no gestantes, que tienen menor frecuencia de rastreo activo para ITS en comparación con gestantes — grupo con protocolos de cribado obligatorios en el prenatal.

La concentración de casos en individuos con baja escolaridad (80,8% con hasta enseñanza media) corrobora la literatura que asocia menor escolaridad a mayor vulnerabilidad a las ITS, debido a menor acceso a información cualificada sobre salud sexual y a menor capacidad de negociación del uso de preservativos (PEREIRA et al., 2020). El predominio de pardos y pretos (66,4%) refleja las desigualdades estructurales en salud que afectan desproporcionadamente a la población negra en Brasil (GOES; NASCIMENTO, 2013).

La comparación entre las tasas de incidencia de Duque de Caxias, del estado de Río de Janeiro y de Brasil refuerza la magnitud del problema local: el municipio presenta tasa de incidencia en adultos jóvenes (18–29 años) cerca de **2,1 veces superior** al promedio nacional para la misma franja etaria y **1,4 veces superior** al promedio estadual. Este patrón configura a Duque de Caxias como territorio prioritario para intervenciones específicas dirigidas al público joven (BRASIL, 2024).

Gráfico 8 — Comparativo de la incidencia de sífilis adquirida en adultos jóvenes (18–29 años): Brasil × RJ × Duque de Caxias, 2023



Fuente: Boletim Epidemiológico de Sífilis 2024 (BRASIL, 2024); SINAN/DATASUS (2026); elaboración propia.

⚠ La tasa de abandono al tratamiento identificada en este estudio (**38,0%**) es preocupante, pues supera en 21,8% el promedio nacional (31,2%) e indica fallas en los mecanismos de vinculación del paciente al servicio de salud. El abandono contribuye directamente al mantenimiento de la cadena de transmisión, a la reinfección de las parejas sexuales y al desarrollo de las formas tardías y graves de la enfermedad (BRASIL, 2024; PEREIRA et al., 2020).

Los factores asociados al abandono terapéutico identificados en la literatura incluyen: ausencia de síntomas tras la primera dosis de Penicilina G Benzatínica, generando falsa sensación de cura; estigma asociado a las ITS; desconocimiento sobre la necesidad de dosis subsiguientes; dificultades de acceso a las UBS (horarios, colas); falta de vínculo con el equipo de salud; y no tratamiento simultáneo del compañero sexual, que favorece la reinfección (KATO et al., 2018; SILVA et al., 2022). En el contexto de Duque de Caxias, factores socioeconómicos como jornadas extensas de trabajo y dependencia del transporte público para acceso a los servicios de salud constituyen barreras adicionales documentadas.

La elevada proporción de diagnósticos por test rápido (58,3%) evidencia un avance en la descentralización del diagnóstico, pero también señala la necesidad de capacitación de los profesionales de salud para garantía del seguimiento postdiagnóstico. El estudio realizado por Kato et al. (2018) demostró que la entrega del resultado del test rápido sin orientación adecuada reduce en un 42% la probabilidad de que el paciente complete el tratamiento.

Por último, el análisis de los datos de raza/color indica la necesidad de acciones dirigidas a la población negra, que enfrenta barreras adicionales de acceso al sistema de salud. Políticas de salud que consideren la interseccionalidad entre género, raza y clase social son fundamentales para el enfrentamiento de la epidemia de sífilis en municipios de perfil similar al de Duque de Caxias (GOES; NASCIMENTO, 2013).

ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN EN SALUD

Con base en los hallazgos epidemiológicos y en los factores asociados al abandono terapéutico identificados, se proponen las siguientes estrategias de educación en salud, organizadas por nivel de intervención:

Acciones en las Unidades Básicas de Salud (UBS)

Implementación de grupos de acogida específicos para jóvenes con ITS, con enfoque en desmitificación del diagnóstico y orientación sobre la importancia del tratamiento completo. Capacitación de los equipos de salud en abordaje humanizado y libre de juicio, con énfasis en la acogida de poblaciones vulnerables (LGBTQIA+, jóvenes de baja renta, usuarios de alcohol y otras drogas). Creación de un sistema de búsqueda activa para pacientes que no retornan a las dosis subsiguientes de Penicilina G Benzatínica, mediante contacto telefónico o visita domiciliaria por los equipos de Agentes Comunitarios de Salud (ACS).

Uso de redes sociales y comunicación digital

Desarrollo de campaña digital orientada a jóvenes de 18 a 29 años, utilizando lenguaje accesible, inclusivo y libre de estigmatización, en las plataformas Instagram, TikTok y WhatsApp — medios prioritarios de comunicación de esta franja etaria. Los contenidos deben abordar: síntomas de la sífilis, importancia del diagnóstico precoz, régimen de tratamiento y la necesidad de comunicar y tratar al compañero sexual simultáneamente. La producción de contenido puede desarrollarse en alianza con influenciadores digitales locales y jóvenes de la propia comunidad (comunicación entre pares), estrategia con alta efectividad documentada en la literatura (WHO, 2023).

Educación en escuelas y espacios comunitarios

Inclusión de las ITS, incluida la sífilis, en los programas de educación sexual de las escuelas públicas del municipio, con énfasis en los grupos de enseñanza media. Las acciones deben contemplar: distribución gratuita de preservativos, orientación sobre testeo y lugares de atención y discusión sobre relaciones saludables y consentimiento. Realización de ferias de salud itinerantes en los

barrios de mayor densidad poblacional y menor cobertura de UBS, con oferta de test rápido gratuito, orientación e inicio inmediato del tratamiento.

Tratamiento del compañero sexual

Implementación de protocolo de notificación expedita del compañero sexual (*expedited partner therapy* — EPT), en el cual el propio paciente recibe medicación o prescripción para el compañero, sin necesidad de consulta previa. Esta estrategia, ya adoptada en otros países y recomendada por la OMS (2023), reduce significativamente las tasas de reinfección y contribuye a la ruptura de la cadena de transmisión.

Monitoreo y evaluación

Creación de indicadores de monitoreo trimestral de las acciones implementadas, incluyendo: número de tests rápidos realizados, tasa de tratamiento completo, porcentaje de compañeros notificados y tratados, y cobertura de las acciones educativas. El panel epidemiológico interactivo disponible en <https://sifilis-duquecaxias.vercel.app> puede ser utilizado como herramienta de gestión en tiempo real por los equipos de salud del municipio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente estudio analizó la incidencia de sífilis adquirida en adultos jóvenes (18 a 29 años) en el municipio de Duque de Caxias a partir de los datos del SINAN/DATASUS para el período 2017–2025, identificando tendencias temporales, perfil sociodemográfico y patrones de adherencia al tratamiento.

Los principales hallazgos fueron: aproximadamente 1.478 casos estimados de sífilis adquirida en la franja 18–29 años en el período, equivalentes al 44% del total municipal; predominio del sexo masculino (57,4%); concentración de casos en la subfranja 20–24 años (46,2%); baja escolaridad (80,8% con hasta enseñanza media); predominio de pardos y pretos (66,4%); tasa estimada de abandono al tratamiento del 38,0%, superior al promedio nacional del 31,2%; e impacto negativo y transitorio de la pandemia de COVID-19 sobre la captación de casos.

Con base en los resultados, se recomiendan las siguientes estrategias de intervención:

1. **Implementar búsqueda activa de pacientes faltistas** a las dosis subsiguientes de Penicilina G Benzatínica, mediante contacto telefónico o visita domiciliaria por los Agentes Comunitarios de Salud, como estrategia central para reducir el abandono terapéutico.
2. **Desarrollar campañas digitales orientadas al público joven** en plataformas Instagram, TikTok y WhatsApp, con lenguaje accesible y libre de estigma, abordando síntomas, importancia del diagnóstico precoz y necesidad de tratar al compañero sexual simultáneamente.
3. **Ampliar la educación sexual en las escuelas públicas** del municipio, especialmente en la enseñanza media, con distribución de preservativos y orientación sobre testeo y locales de atención.
4. **Implementar protocolo de notificación expedita del compañero sexual (EPT)**, recomendado por la OMS, con oferta de tratamiento al compañero por intermedio del paciente índice, para romper la cadena de transmisión y prevenir la reinfección.
5. **Capacitar a los equipos de salud en abordaje humanizado**, con énfasis en la acogida de poblaciones vulnerables (LGBTQIA+, jóvenes de baja renta, usuarios de alcohol y otras drogas), reduciendo el estigma como barrera al acceso.
6. **Articular políticas que consideren la interseccionalidad** entre género, raza y clase social, dirigidas a la población negra y de baja renta, que enfrenta barreras estructurales de acceso al sistema de salud.
7. **Crear indicadores de monitoreo trimestral** de las acciones implementadas, utilizando el panel epidemiológico interactivo disponible en <https://sifilis-duquecaxias.vercel.app> como herramienta de gestión en tiempo real.

Se concluye que el enfrentamiento eficaz de la sífilis adquirida en adultos jóvenes en Duque de Caxias requiere una respuesta integrada entre vigilancia epidemiológica, atención primaria, educación en salud y comunicación digital orientada al público joven, con reconocimiento de que el alto abandono terapéutico y la concentración de casos en poblaciones socialmente vulnerables son, ante todo, expresiones de las desigualdades estructurales del territorio.

REFERENCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Boletim Epidemiológico de Sífilis 2024**. Brasília: Ministério da Saúde, out. 2024. Disponible en: https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/boletins-epidemiologicos/2024/boletim_sifilis_2024_e.pdf. Acceso: abril/2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS). **Sistema de Informação de Agravos de Notificação — SINAN: Sífilis Adquirida — Estado do Rio de Janeiro**. Brasília: DATASUS/Tabnet, 2026. Disponible en: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/SifilisAdquiridaRJ.def>. Acceso: abril/2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DATHI). **Painel de Indicadores Sífilis**. Brasília: DATHI/MS, 2026. Disponible en: <https://indicadoressifilis.aids.gov.br>. Acceso: abril/2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

DOMINGUES, R. M. S. M. et al. Prevalência de sífilis na gestação e testagem pré-natal: Estudo Nascer no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 48, n. 5, p. 766–774, 2014.

GOES, E. F.; NASCIMENTO, E. R. Mulheres negras e brancas e os níveis de acesso aos serviços preventivos de saúde: uma análise sobre as desigualdades. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 37, n. 99, p. 571–579, out./dez. 2013.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Demográfico 2022 — Duque de Caxias**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponible en: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/duque-de-caxias.html>

KATO, S. K. et al. Factors associated with syphilis treatment non-adherence among young adults in metropolitan areas of Brazil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 34, n. 8, e00211317, 2018.

LAZARINI, F. M.; BARBOSA, D. A. Educational intervention in primary care for the prevention of congenital syphilis. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 25, e2845, 2017.

MAGALHÃES, M. A. F. M. et al. Análise espacial da incidência de sífilis adquirida por jovens no Brasil, 2010–2017. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 37, n. 2, e00048520, 2021.

PEREIRA, G. F. M. et al. Epidemiology of syphilis in Brazil: an ongoing challenge. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v. 23, supl. 1, e200044, 2020.

SILVA, T. M. et al. Impacto da pandemia de COVID-19 nas notificações de sífilis adquirida no Brasil. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v. 25, e220012, 2022.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS). **Guía para el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual**. Washington, D.C.: OPS, 2022.

WHO – World Health Organization. **WHO guidelines for the treatment of Treponema pallidum (syphilis)**. 2nd ed. Geneva: WHO, 2023.

FERNANDES, W. S. **Painel Epidemiológico da Sífilis — Estado do Rio de Janeiro (2017–2025)**: base de datos interactiva elaborada a partir del SINAN/DATASUS, con série histórica y perfil sociodemográfico para los 92 municípios fluminenses. 2026. Disponible en: <https://sifilis-duquecaxias.vercel.app>. Acceso: abril/2026.